Guía de estándar UX/UI para pantallas ABM

Oct 17, 2026 · @Fernando Bono

Propósito y alcance

Esta guía define cómo se construye toda pantalla de ABM (alta, baja, modificación y consulta) del sistema, para que cada entidad se use igual, se aprenda una sola vez y no exponga al usuario a errores evitables.

Aplica a listados, formularios de alta y edición, pantallas de detalle y acciones de desactivación. Es normativa: lo marcado como **Debe** es obligatorio para aprobar un desarrollo; lo marcado como **Conviene** es recomendado.

Cada regla se apoya en un principio de usabilidad conocido, para que el equipo entienda el porqué y pueda resolver casos que la guía no prevé.

Diagnóstico de las pantallas actuales

Las tres pantallas funcionan, pero resuelven el mismo problema de tres formas distintas y dejan al usuario sin feedback, sin atajos y con acciones destructivas demasiado expuestas.

Pantalla	Problema observado	Principio afectado	Gravedad
Médicos (listado)	El campo "Buscar" no dice qué busca (¿nombre, matrícula, especialidad?) ni tiene placeholder	Reconocer antes que recordar	Media
Médicos (listado)	No hay filtros por especialidad ni por estado de agenda, que son las preguntas más frecuentes	Flexibilidad y eficiencia	Alta
Médicos (listado)	No hay contador de resultados, paginación ni orden por columna	Visibilidad del estado del sistema	Media
Médicos (listado)	El estado de agenda es texto plano; "Sin agenda (rige desde 16/11)" es ambiguo: no queda claro si algo empieza o termina	Lenguaje del usuario	Alta

Pantalla	Problema observado	Principio afectado	Gravedad
Médicos (listado)	La única acción es el link del nombre; no se ven Editar ni Desactivar	Visibilidad, affordance	Media
Médicos (listado)	Conviven datos de prueba ("Sonda4E653A4A", hashes) con datos reales	Confianza, prevención de errores	Alta
Detalle de médico	Se entra directo en modo edición: no hay vista de solo lectura	Prevención de errores	Media
Detalle de médico	No hay botón Cancelar ni aviso al salir con cambios sin guardar	Control y libertad del usuario	Alta
Detalle de médico	No se marcan campos obligatorios ni el formato esperado de la matrícula	Prevención de errores	Media
Detalle de médico	"Estado de agenda" se muestra pero no ofrece cómo gestionarla	Visibilidad, próximos pasos	Media
Detalle de médico	"Usuario del sistema: Sin usuario" no explica para qué sirve vincularlo	Ayuda y documentación	Baja
Especialidades	Un botón rojo "Desactivar" en cada fila: ruido visual y riesgo de clic accidental	Prevención de errores, ley de Fitts	Alta
Especialidades	El alta inline compite con el listado y difiere del patrón de Médicos (botón "Nuevo médico")	Consistencia y estándares	Media
Especialidades	No hay búsqueda, edición del nombre ni forma de ver o reactivar las inactivas	Control y libertad del usuario	Alta
Especialidades	La columna Estado repite "Activa" en todas las filas y no aporta información	Diseño minimalista	Baja
Especialidades	No se informa cuántos médicos usan cada especialidad antes de desactivarla	Prevención de errores	Alta

Principios de usabilidad que rigen el estándar

Toda decisión de esta guía se justifica con uno de estos principios; ante un caso no previsto, se resuelve con ellos.

Principio	Qué exige en un ABM
Visibilidad del estado del sistema (Nielsen 1)	Cada acción muestra resultado: cargando, guardado, error. El listado dice cuántos registros hay y qué filtro está aplicado.
Correspondencia con el mundo real (Nielsen 2)	Términos del negocio, no de la base de datos. Estados con nombres que el usuario usaría en voz alta.
Control y libertad del usuario (Nielsen 3)	Siempre hay Cancelar, Volver y Deshacer. Lo desactivado se puede reactivar.
Consistencia y estándares (Nielsen 4, ley de Jakob)	Todas las entidades usan el mismo layout, los mismos verbos y las mismas posiciones de botones.
Prevención de errores (Nielsen 5)	Validar antes de enviar, confirmar lo destructivo, impedir duplicados, mostrar dependencias.
Reconocer antes que recordar (Nielsen 6)	Placeholders, selects con búsqueda, filtros visibles, datos clave en el listado.
Flexibilidad y eficiencia (Nielsen 7)	Búsqueda instantánea, filtros guardados en la URL, atajos de teclado, Enter para enviar.
Diseño estético y minimalista (Nielsen 8)	Solo la información que ayuda a decidir; nada repetido en cada fila.
Ayuda a reconocer y recuperarse de errores (Nielsen 9)	Mensajes junto al campo, en lenguaje claro, diciendo cómo corregir.
Ayuda y documentación (Nielsen 10)	Texto de ayuda breve bajo los campos no obvios.
Proximidad y similitud (Gestalt)	Lo relacionado va junto; acciones del mismo tipo comparten estilo.
Ley de Fitts	Acciones frecuentes grandes y cerca; acciones peligrosas lejos y pequeñas.
Ley de Hick	Pocas opciones visibles a la vez; el resto, en un menú de más acciones.

Principio	Qué exige en un ABM
Jerarquía visual	Un único botón primario por vista; el ojo debe saber dónde ir primero.

Patrón estándar de pantalla de listado

Todo listado tiene cuatro zonas fijas, siempre en este orden: encabezado, barra de filtros, tabla y pie de paginación.

1. Encabezado

- **Debe** mostrar el título en plural ("Médicos") y, a su lado, el total: "Médicos · 124".
- **Debe** ubicar la acción de alta como único botón primario, alineado a la derecha del título: "Nuevo médico".
- **Conviene** sumar acciones secundarias (Exportar, Importar) como botones secundarios o dentro de un menú "Más acciones".

2. Barra de filtros

- **Debe** tener un buscador con placeholder que diga qué busca: "Buscar por apellido, nombre o matrícula".
- **Debe** filtrar mientras se escribe (con debounce de 300 ms) o con Enter; el botón "Buscar" es opcional.
- **Debe** ofrecer filtros por los atributos que el usuario consulta seguido (en Médicos: Especialidad y Estado de agenda), como selects junto al buscador.
- **Debe** mostrar los filtros activos y un enlace "Limpiar filtros".
- **Debe** incluir un filtro de estado "Activos / Inactivos / Todos" en toda entidad con baja lógica, con "Activos" por defecto.
- **Conviene** reflejar búsqueda, filtros, orden y página en la URL, para poder compartir y volver con el botón Atrás.

3. Tabla

- **Debe** usar como primera columna el identificador humano del registro ("Apellido, Nombre"), como enlace al detalle.
- **Debe** alinear texto a la izquierda, números y montos a la derecha, y fechas en formato dd/mm/aaaa.
- **Debe** mostrar estados como badges con texto y color, nunca solo color.
- **Debe** permitir ordenar por columnas clave, con un indicador de orden (▲▼) en el encabezado.

- **Debe** concentrar las acciones por fila en la última columna: una acción frecuente visible (Editar) y el resto en un menú "⋯". Las acciones destructivas nunca se muestran como botón en cada fila.
- **Conviene** fijar el encabezado de la tabla al hacer scroll y resaltar la fila al pasar el mouse.
- **Conviene** mostrar columnas derivadas útiles para decidir: en Especialidades, la cantidad de médicos asociados.

4. Pie

- **Debe** paginar a partir de 25 registros, con texto "Mostrando 1–25 de 124" y selector de 25 / 50 / 100 por página.
- **Debe** paginar del lado del servidor cuando la entidad pueda superar los 500 registros.

Patrón estándar de alta y edición

El formulario se elige por tamaño de la entidad y siempre ofrece guardar, cancelar y corregir sin perder datos.

Dónde vive el formulario

Tamaño de la entidad	Contenedor	Ejemplo
1 a 3 campos simples	Modal o panel lateral, abierto desde el botón "Nueva …"	Especialidad
4 a 12 campos	Página propia	Médico
Más de 12 campos o pasos dependientes	Página con secciones o asistente por pasos	Agenda del médico

El alta nunca se coloca como formulario fijo encima del listado: empuja la tabla hacia abajo y compite con ella.

Detalle frente a edición

- **Debe** abrir el detalle en modo lectura, con un botón "Editar". Así se evita modificar por accidente al solo consultar.
- **Conviene** organizar el detalle en pestañas o secciones (Datos, Agenda, Usuario, Historial) cuando la entidad tiene subrecursos.
- **Debe** mostrar al pie "Creado por / Modificado por" con fecha, para trazabilidad.

Campos

- **Debe** usar una sola columna, con la etiqueta arriba del campo y un ancho máximo de 640 px.
- **Debe** ordenar los campos como el usuario piensa la entidad: identidad, luego clasificación, luego configuración.
- **Debe** marcar los obligatorios con asterisco y una nota "* Obligatorio" al inicio; si casi todos lo son, marcar los opcionales con "(opcional)".
- **Debe** indicar formatos con texto de ayuda debajo del campo: "Ejemplo: MP 1234".
- **Debe** usar el control adecuado: select con búsqueda cuando hay más de 10 opciones, radios cuando hay 2 a 4, interruptor para sí/no.
- **Debe** poner el foco en el primer campo al abrir el formulario.

Validación

- **Debe** validar cada campo al salir de él (blur) y todo el formulario al enviar.
- **Debe** mostrar el error debajo del campo, en rojo y con ícono, diciendo cómo corregirlo: "La matrícula ya está registrada para Pereyra, Martín José".
- **Debe** validar en el servidor también; el cliente es solo comodidad.
- **Debe** detectar duplicados probables (mismo apellido y nombre, misma matrícula) antes de guardar.

Botones y envío

- **Debe** ubicar los botones al pie: primario "Guardar" y secundario "Cancelar", siempre en el mismo orden en todo el sistema.
- **Debe** deshabilitar el botón y mostrar "Guardando…" mientras se procesa, para evitar dobles envíos.
- **Debe** avisar si el usuario intenta salir con cambios sin guardar.
- **Debe**, tras guardar, volver al detalle o al listado y mostrar una notificación: "Médico actualizado".

Baja, desactivación y acciones destructivas

La baja es lógica por defecto, se pide de forma deliberada, informa sus consecuencias y se puede revertir.

- **Debe** usar baja lógica (Activo / Inactivo) en toda entidad referenciada por otras. La eliminación física queda reservada a registros sin dependencias y a perfiles administradores.
- **Debe** ubicar "Desactivar" dentro del menú "⋯" de la fila o en el detalle, en una sección final separada. Nunca como botón rojo repetido en cada fila.

- **Debe** pedir confirmación en un diálogo que nombre el registro y la consecuencia: "¿Desactivar Cardiología? 12 médicos la tienen asignada; no podrá elegirse en nuevos médicos."
- **Debe** rotular los botones del diálogo con el verbo, no con Sí/No: "Desactivar especialidad" (rojo) y "Cancelar" (secundario, con el foco por defecto).
- **Debe** bloquear la baja cuando rompe una regla de negocio y explicar por qué: "No se puede desactivar: hay turnos futuros asignados".
- **Debe** ofrecer "Reactivar" para los registros inactivos, visibles con el filtro de estado.
- **Conviene** mostrar una notificación con "Deshacer" durante 5 a 8 segundos tras desactivar.
- **Conviene**, en bajas masivas o irreversibles, pedir que el usuario escriba el nombre del registro para confirmar.

El color rojo se reserva para la acción destructiva confirmada y para errores. Usarlo en cada fila lo vuelve ruido y le quita fuerza de alerta.

Estados, estados vacíos y feedback

El usuario nunca debe preguntarse si algo pasó: cada estado del sistema y de los datos tiene una representación definida.

Estados de negocio como badges

Cada entidad con estados publica su tabla de estados: nombre visible, color, significado y si admite acción. Ejemplo propuesto para el estado de agenda:

Estado visible	Color del badge	Significado	Reemplaza a
Vigente	Verde	Tiene agenda activa hoy	"Vigente"
Programada · desde 16/11/2026	Azul	Tiene agenda aprobada que empieza en esa fecha	"Sin agenda (rige desde 16/11)"
Pendiente de aprobación	Ámbar	Hay una propuesta de agenda esperando revisión	"Propuesta pendiente"
Sin agenda	Gris	No tiene agenda cargada ni programada	"Sin agenda"

Si un médico tiene agenda vigente y otra programada, se muestra la vigente y debajo, en texto pequeño, "Cambia el 16/11/2026".

Estados de la interfaz

- **Carga:** esqueletos de filas (skeleton) en tablas; spinner solo en botones.
- **Vacío inicial:** ilustración o ícono, una frase y la acción: "Todavía no hay especialidades. Creá la primera." con el botón "Nueva especialidad".
- **Sin resultados:** "No hay médicos que coincidan con 'Pereira'" y un enlace "Limpiar filtros". Es distinto del vacío inicial.
- **Error de carga:** mensaje claro y botón "Reintentar"; nunca una pantalla en blanco ni un stack trace.
- **Éxito:** notificación (toast) arriba a la derecha, 4 segundos, con el verbo en pasado: "Especialidad creada".
- **Error al guardar:** el formulario conserva lo cargado y muestra el error junto al campo o en un resumen arriba del formulario.

Diseño visual

La base visual se toma de Bootstrap 5, que el sistema ya usa, y se fija en tokens para que todas las pantallas se vean iguales.

Jerarquía de botones

Nivel	Estilo	Uso	Cantidad por vista
Primario	Relleno, color de marca	La acción principal (Nuevo, Guardar)	Una
Secundario	Borde, sin relleno	Alternativas (Cancelar, Exportar, Buscar)	Pocas
Terciario	Enlace	Navegación y acciones menores (Volver, Limpiar filtros)	Libre
Peligro	Relleno rojo	Solo dentro del diálogo de confirmación	Una

Espaciado y tipografía

- Grilla de 8 px: márgenes y separaciones en 8, 16, 24, 32 px.
- Escala tipográfica fija: título de página 28 px, subtítulo 20 px, cuerpo 16 px, texto de ayuda 14 px.
- Separar el encabezado de la página de su contenido con 24 px como mínimo; agrupar campos relacionados con 16 px y separar grupos con 32 px (proximidad).

Color

- Colores semánticos únicos: verde = éxito o vigente, ámbar = pendiente o atención, rojo = error o peligro, azul = información o programado, gris = inactivo o neutro.
- El color nunca es el único portador del significado: siempre va acompañado de texto o ícono.

Tablas

- Altura de fila de 48 px; densidad compacta de 36 px opcional para listados largos.
- Separadores horizontales suaves, sin bordes verticales.

Hoja de estilos única y tokens de diseño

Todo el aspecto visual sale de una sola hoja de estilos del sistema; ninguna vista define colores, tamaños ni tipografías por su cuenta.

- **Debe** existir un archivo de tokens (`tokens.css` o `_variables.scss`) con colores, tipografía, espaciados, radios y sombras como variables CSS.
- **Debe** personalizarse Bootstrap a partir de esos tokens (variables Sass o `--bs-*`), no sobrescribiendo clases en cada pantalla.
- **Debe** prohibirse el estilo inline (`style="…"`) y los colores en hexadecimal fuera del archivo de tokens; se controla en la revisión de código o con Stylelint.
- **Debe** haber clases de componente reutilizables para lo que se repite: `.badge-estado--vigente` , `.page-header` , `.filter-bar` , `.table-actions` .
- **Conviene** publicar una página interna de referencia ("style guide" viva) que muestre cada componente con su código, y versionar la hoja de estilos.

```
:root {
  /* Color de marca y semánticos */
  --color-primario: #1f5fa8;
  --color-exito: #1e7e34;
  --color-atencion: #b26a00;
  --color-peligro: #c62828;
  --color-info: #1565c0;
  --color-neutro: #6c757d;

  /* Tipografía */
  --fuente-base: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --texto-titulo: 1.75rem;   /* 28 px */
  --texto-subtitulo: 1.25rem; /* 20 px */
  --texto-cuerpo: 1rem;      /* 16 px */
  --texto-ayuda: 0.875rem;   /* 14 px */

  /* Espaciado (grilla de 8 px) */
  --esp-1: 0.5rem;
  --esp-2: 1rem;
```

```
  --esp-3: 1.5rem;
  --esp-4: 2rem;

  --radio: 0.5rem;
}

.badge-estado--vigente   { background: color-mix(in srgb, var(--color-exito)
15%, white);   color: var(--color-exito); }
.badge-estado--pendiente { background: color-mix(in srgb, var(--color-
atencion) 15%, white); color: var(--color-atencion); }
```

Los valores de color del ejemplo son ilustrativos: se reemplazan por la paleta institucional y se verifica su contraste AA.

Accesibilidad y responsive

El nivel mínimo exigido es WCAG 2.2 AA: una pantalla que no lo cumple no se considera terminada.

Accesibilidad

- **Debe** tener contraste de 4,5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande y controles.
- **Debe** asociar cada etiqueta a su campo (`<label for>`) y cada error al campo con `aria-describedby`.
- **Debe** poder operarse completo con teclado: Tab en orden lógico, Enter para enviar, Esc para cerrar diálogos.
- **Debe** mostrar el foco con un contorno visible; nunca `outline: none` sin reemplazo.
- **Debe** anunciar notificaciones con `aria-live` y devolver el foco al elemento que abrió un diálogo al cerrarlo.
- **Debe** tener áreas de clic de al menos 44 × 44 px en táctil y 24 × 24 px en escritorio.
- **Debe** dar nombre accesible a los botones de solo ícono (`aria-label="Más acciones para Ríos, Pablo"`).

Responsive

- Desde 992 px: tabla completa.
- Entre 768 y 991 px: se ocultan columnas secundarias; los filtros pasan a un panel desplegable.
- Menos de 768 px: cada fila se convierte en tarjeta con el nombre, el badge de estado y el menú "⋯"; el botón de alta queda fijo abajo.
- Los formularios ocupan el 100 % del ancho en celular y los botones se apilan con el primario arriba.

Microcopy y nomenclatura

Los mismos verbos y formatos en todo el sistema hacen que el usuario no tenga que reaprender cada pantalla.

Situación	Texto estándar	Evitar
Crear	"Nuevo médico" / "Nueva especialidad"	"Agregar", "Alta", "Crear registro" mezclados
Guardar edición	"Guardar"	"Guardar cambios" en unas pantallas y "Aceptar" en otras
Salir sin guardar	"Cancelar"	"Cerrar", "Volver" como sinónimos
Baja lógica	"Desactivar" / "Reactivar"	"Eliminar" cuando no se elimina
Volver al listado	"← Médicos" (migas de pan)	"Volver a Médicos" suelto
Confirmación	"¿Desactivar Cardiología?"	"¿Está seguro?"
Éxito	"Médico creado"	"Operación exitosa"
Error	"Ingresá una matrícula. Ejemplo: MP 1234"	"Campo inválido", "Error 500"

Formatos

- Personas: "Apellido, Nombre" en listados; "Nombre Apellido" en textos corridos.
- Fechas: dd/mm/aaaa siempre con año; fechas relativas ("hace 2 días") solo con la fecha exacta en tooltip.
- Mayúscula solo al inicio de títulos y botones ("Nuevo médico", no "Nuevo Médico").
- Un mismo tratamiento en todo el sistema: voseo o usted, sin mezclar.

Datos de prueba

Los ambientes que ven usuarios (demo, UAT, producción) no deben mostrar registros generados por tests automáticos con hashes en el nombre. Los tests limpian lo que crean o corren en una base aislada; los datos de demostración usan nombres verosímiles.

Navegación y menú principal

El menú debe decirle al usuario dónde está, qué puede hacer y dónde encontrar cada cosa, con las opciones agrupadas por tarea y no en una lista plana de enlaces.

Diagnóstico del menú actual

Problema observado	Principio afectado	Gravedad
No se marca la opción activa: estando en Especialidades, el menú se ve igual	Visibilidad del estado del sistema	Alta
Ocho enlaces en una lista plana, sin grupos	Ley de Hick, proximidad (Gestalt)	Media
Lo relacionado con agenda está disperso: Propuestas de agenda, Bloqueos de agenda y Agendas aparecen separados	Proximidad, modelo mental	Media
Las opciones lucen como hipervínculos subrayados, no como navegación	Consistencia y estándares	Baja
"Salir" está junto al nombre, arriba de todo y al alcance de un clic accidental	Prevención de errores, ley de Fitts	Media
No hay indicadores de trabajo pendiente (propuestas a revisar, pacientes a avisar)	Visibilidad del estado del sistema	Media
No hay versión para pantallas chicas ni opción de contraer	Flexibilidad y eficiencia	Media

Estructura de la aplicación

- **Debe** usar un marco fijo: barra superior con el nombre del sistema a la izquierda y el menú de usuario a la derecha; menú lateral a la izquierda; contenido a la derecha.
- **Debe** ubicar "Cerrar sesión" dentro del menú de usuario (nombre ▾), junto con "Mi perfil" y "Cambiar contraseña".
- **Debe** mostrar migas de pan en el contenido ("Catálogos / Especialidades") y que el título de la página coincida con el texto del menú.

Menú lateral

- **Debe** agrupar las opciones por tarea, con un rótulo por grupo y no más de 7 opciones por grupo.
- **Debe** ordenar los grupos por frecuencia de uso: primero la operación diaria, al final la administración.
- **Debe** resaltar la opción activa con fondo, barra lateral de color y texto en negrita, y marcarla con `aria-current="page"`.
- **Debe** mostrar cada opción como un ítem de navegación (ícono + texto, sin subrayado) con un área de clic de al menos 40 px de alto.

- **Debe** mostrar solo las opciones que el rol del usuario puede usar; nunca opciones que llevan a "acceso denegado".
- **Conviene** mostrar contadores en las opciones con trabajo pendiente ("Propuestas de agenda 3").
- **Conviene** permitir contraer el menú a solo íconos (con el texto como tooltip) y recordar esa preferencia.
- **Debe**, en pantallas de menos de 992 px, ocultar el menú detrás de un botón ☰ que lo abre como panel superpuesto.

Agrupación propuesta para Las Acacias

Grupo	Opciones
Agenda	Agendas · Propuestas de agenda · Bloqueos de agenda · Pacientes para avisar
Catálogos	Médicos · Especialidades
Administración	Usuarios del personal · Auditoría

Menú agrupado por tarea, con la opción activa resaltada



Maqueta · marco de la aplicación y menú lateral

El menú de usuario se muestra abierto para ver qué contiene; los contadores 3 y 5 son de ejemplo. Los cuadrados representan íconos a definir.

Aplicación: rediseño de las tres pantallas

Aplicando el estándar, las tres pantallas pasan a compartir el mismo esqueleto y solo cambian sus columnas y campos.

Médicos (listado)

1. Encabezado: "Médicos · 124" a la izquierda y "Nuevo médico" (primario) a la derecha.
2. Filtros en una línea: buscador "Buscar por apellido, nombre o matrícula", select Especialidad (con búsqueda), select Estado de agenda, select Activos/Inactivos/Todos y "Limpiar filtros".
3. Columnas: Médico (enlace) · Matrícula · Especialidad · Estado de agenda (badge) · Acciones (Editar + "⋯" con Ver agenda, Vincular usuario, Desactivar).
4. Pie: "Mostrando 1–25 de 124" y paginación.

Médicos: filtros visibles, estados como badges, acciones al final



Maqueta · listado de Médicos

Los números marcan las cuatro zonas fijas de la lista anterior. Las matrículas son de ejemplo; el menú ⋯ agrupa Ver agenda, Vincular usuario y Desactivar.

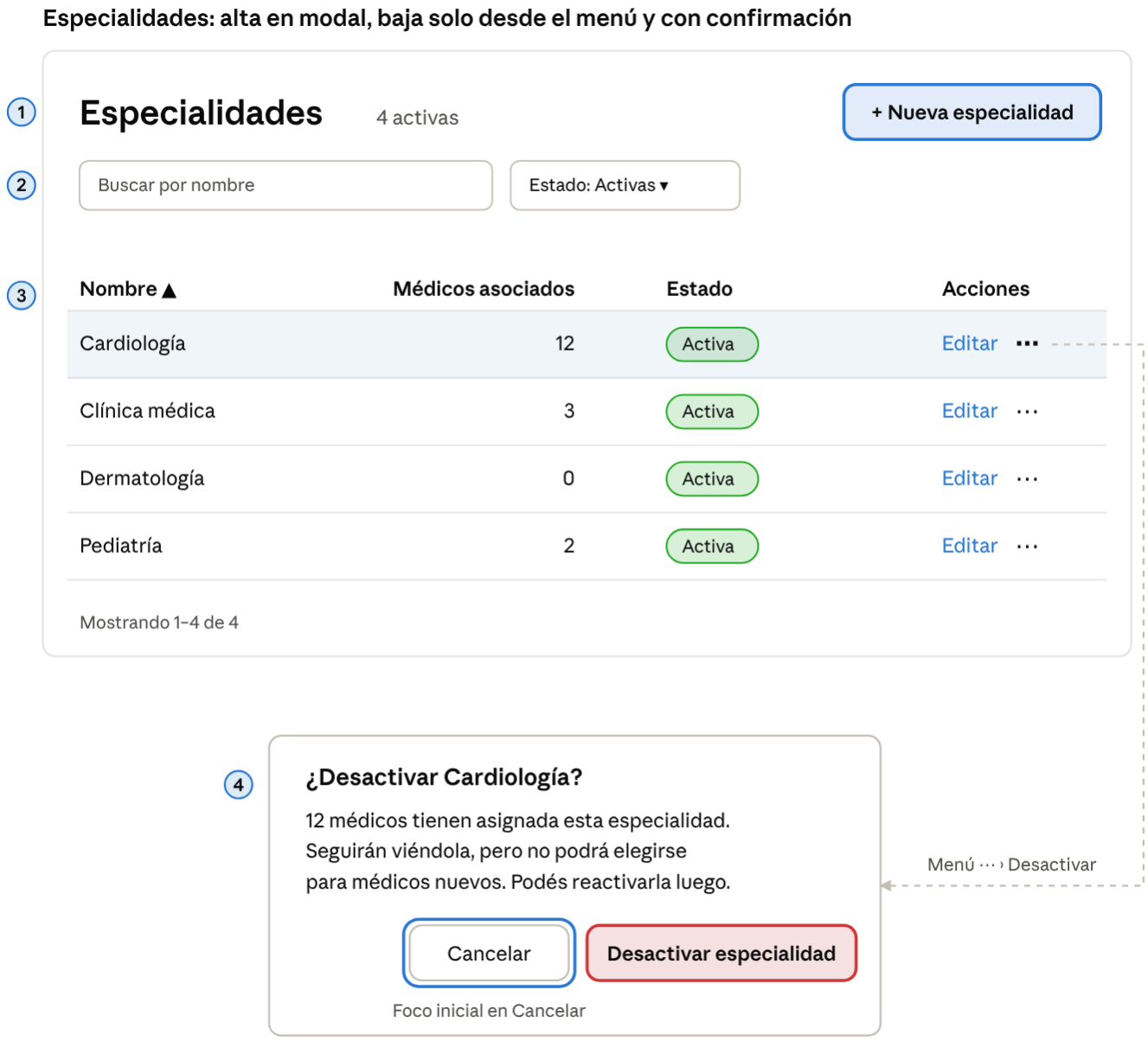
Detalle de médico

1. Migas de pan "Médicos / Ríos, Pablo" y título con badge de estado de agenda al lado del nombre.
2. Pestañas: Datos · Agenda · Usuario del sistema · Historial.

3. Pestaña Datos en modo lectura, con botón "Editar"; al editar aparecen "Guardar" y "Cancelar" al pie.
4. Matrícula con ayuda "Ejemplo: MP 1234" y validación de duplicados.
5. Usuario del sistema con ayuda: "Vinculalo para que el médico pueda ver y gestionar su agenda".
6. Al final de Datos, sección "Desactivar médico" separada, con explicación de la consecuencia.

Especialidades

1. Encabezado: "Especialidades · 18" y "Nueva especialidad" (primario), que abre un modal de un campo.
2. Filtros: buscador por nombre y select Activas/Inactivas/Todas.
3. Columnas: Nombre · Médicos asociados · Estado (badge, útil cuando se filtra "Todas") · Acciones (Editar + "⋯" con Desactivar o Reactivar).
4. Desactivar abre la confirmación con la cantidad de médicos afectados.
5. El alta valida nombres duplicados sin distinguir mayúsculas ni tildes ("Cardiologia" = "Cardiología").



Maqueta · Especialidades y confirmación de baja

Ya no hay un botón rojo por fila: la baja se pide desde el menú ··· y el diálogo informa cuántos médicos quedan afectados. Las cantidades son de ejemplo.

Checklist de revisión para cada ABM

Un ABM se aprueba cuando cumple todos estos puntos; se usa en la revisión de código y en las pruebas de aceptación.

Listado

- [ ] Título en plural con total de registros
- [ ] Un único botón primario "Nuevo …"
- [ ] Buscador con placeholder que indica los campos buscados

- [ ] Filtros por los atributos más consultados y filtro Activos/Inactivos/Todos
- [ ] Filtros, orden y página reflejados en la URL
- [ ] Estados como badges con texto
- [ ] Acciones por fila en la última columna; las destructivas dentro del menú "⋯"
- [ ] Paginación con "Mostrando x–y de z"
- [ ] Estado vacío inicial y estado sin resultados diferenciados

Formulario y detalle

- [ ] Detalle en modo lectura con botón "Editar"
- [ ] Una columna, etiquetas arriba, obligatorios marcados
- [ ] Texto de ayuda en campos con formato
- [ ] Validación al salir del campo y en el servidor, con mensajes que dicen cómo corregir
- [ ] "Guardar" y "Cancelar" al pie, en el orden estándar
- [ ] Botón deshabilitado mientras guarda
- [ ] Aviso al salir con cambios sin guardar
- [ ] Notificación de éxito tras guardar

Baja

- [ ] Baja lógica con opción de reactivar
- [ ] Confirmación que nombra el registro y la consecuencia
- [ ] Botones del diálogo con verbo, foco en Cancelar
- [ ] Bloqueo explicado cuando hay dependencias

Accesibilidad y presentación

- [ ] Contraste AA verificado
- [ ] Operable completo con teclado y foco visible
- [ ] Vista en celular como tarjetas
- [ ] Textos según la tabla de microcopy
- [ ] Sin datos de prueba visibles en ambientes de usuario

Navegación

- [ ] Opción activa resaltada y con `aria-current="page"`
- [ ] La pantalla nueva está en el grupo de menú que le corresponde
- [ ] Título de página igual al texto del menú y migas de pan presentes
- [ ] Visible solo para los roles autorizados
- [ ] Contador de pendientes, si la pantalla tiene trabajo por resolver